



이상지질혈증 분류 기준

단위: mg/dL

총콜레스테롤		LDL 콜레스테롤		중성지방		HDL 콜레스테롤	
높음	≥ 240	매우 높음	≥ 190	매우 높음	≥ 500	높음	≥ 60
경계	200-239	높음	160-189	높음	200-499	낮음	< 40
적정	< 200	경계치	130-159	경계	150-199		
		정상	100-129	적정	< 150		
		적정	< 100				

심혈관 위험도에 따른 LDL 콜레스테롤 및 non-HDL 콜레스테롤의 목표치

위험도	LDL 콜레스테롤 (mg/dL)	non-HDL 콜레스테롤 (mg/dL)
관상동맥질환 ¹⁾ *	< 55	< 85
죽상경화성 허혈뇌졸중 및 일과성허혈발작* 경동맥질환* 말초동맥질환* 복부대동맥류* 당뇨병 (유병기간 10년 이상 또는 주요 심혈관질환 위험인자 [†] 또는 표적장기손상을 동반한 경우) ²⁾	< 70	< 100
당뇨병(유병기간 10년 미만, 주요 심혈관질환 위험인자 [†] 가 없는 경우)	< 100	< 130
중증도 위험군 (주요 심혈관질환 위험인자 [†] 2개 이상)	< 130	< 160
저위험군 (주요 심혈관질환 위험인자 [†] 1개 이하)	< 160	< 190

*LDL 콜레스테롤 기저치 대비 50% 이상 감소시키는 것을 동시에 권고

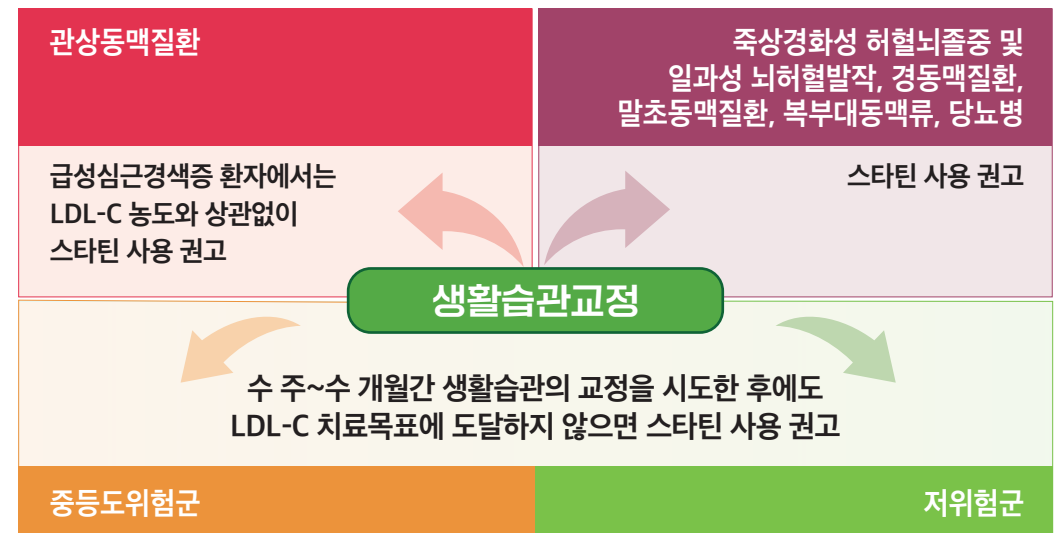
[†]연령(남자 ≥ 45세, 여자 ≥ 55세), 조기 심혈관질환 발생 가족력, 고혈압, 흡연, 낮은 HDL 콜레스테롤 수치(< 40 mg/dL)

1) 급성심근경색증은 기저치 LDL 콜레스테롤 농도와 상관없이 스타틴을 투약

2) 표적장기손상(알부민뇨, 만성콩팥병(추정사구체여과율 60 mL/min/1.73 m² 미만), 망막병증, 신병증, 좌심실비대) 또는
3개 이상의 주요 심혈관질환 위험인자[†]를 동반한 당뇨병의 경우: LDL 콜레스테롤 목표치 < 55 mg/dL 선택적 고려 가능

약물요법

- 일차 치료 약제로 스타틴 사용을 권고한다.
- 스타틴을 투여한 후에도 LDL 콜레스테롤 농도가 치료 목표에 도달하지 않을 경우 스타틴의 용량을 최대한 증량시켜 치료 목표에 도달하도록 조절할 것을 권고한다.
- 내약 가능한 최대 용량의 스타틴 사용에도 불구하고 LDL 콜레스테롤 치료 목표에 도달하지 못하는 경우에 콜레스테롤 흡수억제제(에제티미브)를 병용할 것을 권고한다.
- 고용량의 스타틴 치료에도 불구하고 LDL 콜레스테롤 치료 목표에 도달하지 못하는 경우에 담즙산 제거제를 병용할 수 있다.
- 죽상경화성 심혈관질환이 있었던 환자에게 최대 가용 용량의 스타틴 단독 또는 에제티미브를 병용하여도 LDL 콜레스테롤 치료 목표에 도달하지 못하는 경우 PCSK9 억제제의 병용사용을 고려한다.
- 콜레스테롤 흡수저해제(에제티미브)는 스타틴 불내성이 있는 경우 단독 투여를 고려할 수 있다.
- 죽상경화성 심혈관질환이나 당뇨병 환자에서 생활 습관 개선 및 스타틴 투약 후에도 200 mg/dL 이상의 고중성지방혈증이 지속될 때, 심혈관질환의 예방을 위하여 IPE (하루 4g)를 추가 투약하는 것을 고려할 수 있다.
- 죽상경화성 심혈관질환이나 당뇨병 환자에서 생활 습관 개선 및 스타틴 투약 후에도 200 mg/dL 이상의 고중성지방혈증이 지속될 때, 심혈관질환의 예방을 위하여 피브린산 유도체를 추가 투약하는 것을 고려할 수 있다.
- 죽상경화성 심혈관질환이나 당뇨병 환자에서 생활 습관 개선 및 스타틴 투약 후에도 200 mg/dL 이상의 고중성지방혈증이 지속될 때, 심혈관질환의 예방을 위하여 EPA와 DHA를 혼합한 오메가-3 지방산을 추가 투약하는 것을 고려할 수 있다.



위 정보를 뒷받침하는 근거의 세부사항은 사이트를 통해 전체 가이드라인 정보를 확인할 수 있습니다.

임상진료지침 정보센터 www.guideline.or.kr | 일차 의료용 근거기반 디지털 가이드라인 www.digitalcpg.kr



치료약제

스타틴: HMG-CoA 환원효소 억제제

용법/용량	lovastatin: 20-80 mg/일, 저녁식사와 함께 복용
	pravastatin: 10-40 mg/일, 저녁시간 투여가 더 효과적임
	simvastatin: 20-40 mg/일, 저녁시간 투여가 더 효과적임
	fluvastatin: 20-80 mg/일, 저녁시간 투여가 더 효과적임
	atorvastatin: 10-80 mg/일, 복용시간에 큰 영향을 받지 않음
	rosuvastatin: 5-20 mg/일, 복용시간에 큰 영향을 받지 않음
	pitavastatin: 1-4 mg/일, 복용시간에 큰 영향을 받지 않음
추적 검사	지질지표, 간기능 검사, 근육 효소 (설명할 수 없는 근육통이나 근력 약화가 있는 경우)
부작용	소화장애, 속쓰림, 복통, 간 독성, 근육 독성, 당뇨병
금기증	활동성 또는 만성간질환이 있는 경우, 임신 혹은 수유부는 절대적 금기이며, cyclosporin, macrolide 항생제, 항진균제, cytochrome P-450 억제제 등 다른 약제와 병용 투여할 시에는 상대적 금기로 특별한 주의가 필요함.

에제티미브

용법/용량	10 mg 제제를 1일 1회 복용
추적 검사	지질지표
부작용	복통, 설사, 소화불량, 위식도 역류, 식욕 감소, 관절통, 근육 연축, 홍통, 피로감, transaminase의 상승, gamma-glutamyltransferase의 상승, creatine kinase 상승
금기증	약물에 대한 과민 반응, 임신부와 수유부, 급성간질환이나 중등도 이상의 만성간기능 저하 환자

PCSK9 억제제

용법/용량	alirocumab: 75 mg 또는 150 mg 피하주사
	evolocumab: 140 mg/mL 2주 간격 또는 420 mg 1달 간격 피하주사
추적 검사	지질지표 기능 검사
부작용	주사부위 이상 반응
금기증	alirocumab 또는 evolocumab에 과민 반응

피브린산 유도체

용법/용량	bezafibrate: 400-600 mg/일, 1일 1-3회, 식후
	fenofibrate: 160-200 mg/일, 1일 1회, 식후 즉시
추적 검사	지질지표, 간기능 검사, 신기능 검사, 근육 효소 (설명할 수 없는 근육통이나 근력 약화가 있는 경우)
부작용	소화장애, 근육병증
금기증	심한 간질환 및 담낭질환, 피브린산에 대한 약물 과민 반응이 있는 경우 절대 금기, 신장 기능이 저하되어 있는 경우 주의가 필요함.

오메가-3 지방산

용법/용량	1일 2-4 g
추적 검사	혈중 콜레스테롤, 중성지방, 간기능 검사를 3-6개월마다 시행
부작용	출혈성 뇌졸중, 혈당 상승, 면역 억제 효과, 구역, 구토, 트림, 생선 냄새가 나는 트림이나 생선 맛을 느낌, 간수치 상승, 두통, 가려움증, 관절통
금기증	약물에 대한 과민 반응

[출처. 한국지질·동맥경화학회. 이상지질혈증 진료지침 제5판. 2022.]